TEMA 36 · Cuidados de enfermería a pacientes al final de la vida. Principales problemas. Dolor y escalas de medida. Duelo. Apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados en procesos crónicos

Resumen OPE Enfermería SMS · Cuidados paliativos (dolor total, NECPAL, Karnofsky, ECOG), agonía y sus síntomas, sedación paliativa, LET, eutanasia e instrucciones previas, dolor y escalas (EVA, Campbell, PAINAD, Abbey), vía subcutánea, escalera de la OMS, duelo (Kübler-Ross, Worden, tipos), cuidador (Zarit) y paciente crónico (Ollero, gestora de casos, valoración geriátrica)

1. Cuidados paliativos

- **Cicely Saunders** (movimiento *hospice*): concepto de **dolor total**: dimensiones **física, emocional, social y espiritual**.
- Principios (OMS/SECPAL): aliviar el dolor y los síntomas, **afirmar la vida y ver la muerte como un proceso natural**, **no acelerar ni retrasar la muerte**, integrar lo psicológico y espiritual, ayudar a vivir lo más activamente posible, **apoyar a la familia** (también en el duelo) y trabajar **en equipo**. Prima la **calidad de vida** sobre la cantidad.
- **NECPAL CCOMS-ICO** (identifica necesidades paliativas en **cualquier enfermedad crónica avanzada, no solo cáncer**): **pregunta sorpresa** «¿le sorprendería que muriera en los próximos **12 meses**?»; si la respuesta es **no**, se buscan criterios objetivos: **indicadores generales** (pérdida de peso > 10% en 6 meses, deterioro funcional o cognitivo, síndromes geriátricos, ingresos repetidos) y **específicos** de cada enfermedad (insuficiencia cardíaca NYHA IV, EPOC con oxígeno domiciliario, demencia FAST 7...).
- **Paliativos pediátricos**: 4 grupos (curación posible que puede fallar, muerte prematura inevitable, progresivas sin curación, irreversibles no progresivas). Cribado de síntomas en niños de 4-7 años: **mini-SSPedi** (3 respuestas con dibujos).
- **Karnofsky** (100 = normal, 0 = muerte, saltos de 10): **< 50%** necesita asistencia continua; **≤ 20%** encamado: agonía próxima. **ECOG** (0-5): **0 actividad normal**, **3 encamado > 50% del día**, **4 encamado total**, **5 muerte**. Karnofsky 40 ≈ ECOG 3.

2. Situación de últimos días (agonía)

- Suspender lo **fútil** (analíticas, constantes, sueros que encharcan). Signos más frecuentes: **disfagia a líquidos**, **bajada del nivel de conciencia** y **encamamiento** (Karnofsky < 20).

Problema	Cuidados	Fármaco
Estertores (secreciones que suenan)	**Decúbito lateral o Sims** con la cabeza elevada; **no aspirar en profundidad** (ineficaz, molesta y produce más moco)	**Butilbromuro de escopolamina SC** (no pasa la barrera hematoencefálica: no seda ni agita)
Disnea	Ambiente fresco, **aire dirigido a la cara** (estimula el trigémino y alivia)	**Morfina** (primera línea)
Delirium / agitación	Ambiente tranquilo, orientación	**Haloperidol**; si hay mucha agitación, **levomepromazina**; si falla, midazolam

- Conceptos:
- **Adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico (LET)**: **no iniciar o retirar** tratamientos de soporte (ventilación, diálisis, nutrición artificial) que no aportan beneficio: evita la **obstinación terapéutica**.
- **Sedación paliativa**: reducir la conciencia de forma **proporcionada** para aliviar un **síntoma refractario** (el que **no se controla** con los tratamientos disponibles en un tiempo razonable; un síntoma **difícil** sí acaba respondiendo). **Sedación en la agonía**: en los últimos días, continua y tan profunda como haga falta.
- **Eutanasia**: el profesional **provoca la muerte** a petición expresa, voluntaria y reiterada del paciente.
- **Requisitos de la sedación**: enfermedad avanzada, **síntoma refractario**, **consentimiento** (del paciente o, si no puede, de su representante o familia) y registro en la historia. No es correcta a petición solo de la familia ni por agotamiento del equipo.

- **Fármacos**: midazolam de **primera elección** (SC o IV; IV a mitad de dosis); **levomepromazina** si predomina el **delirium**; **fenobarbital** en tercera línea (**vía e infusor propios**, sin mezclar; antes se retiran benzodiacepinas y neurolépticos y se reduce el opioide a la mitad); **propofol** solo en el hospital. **Los opioides no se usan para sedar** (producen neurotoxicidad: mioclonías, delirium); se **mantienen a su dosis** para el dolor o la disnea.
- **Marco legal**:
- **Instrucciones previas** (Ley 41/2002): documento de una persona **mayor de edad, capaz y libre** con los cuidados que desea o rechaza para cuando no pueda expresarse; puede nombrar un **representante**.
- **Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia (LORE)**: nacionalidad o residencia legal, **mayor de edad**, **capaz y consciente** al pedirla, con **enfermedad grave e incurable** o **padecimiento grave, crónico e imposibilitante**. Dos modalidades: **administración directa** por el profesional o **prescripción para que el paciente se la autoadministre**.

3. Dolor

- **Nociceptivo**: **somático** (bien **localizado**: hueso, metástasis óseas) y **visceral** (**difuso**, cólico, referido, con **cortejo vegetativo**: náuseas, sudor). **Neuropático** (lesión del sistema nervioso: **quemazón, descargas, alodinia**): necesita **coadyuvantes** (gabapentina, pregabalina, antidepresivos). **Mixto**.
- **Basal** (continuo, analgesia pautada) e **irruptivo** (crisis breves, < 30-60 min, con dolor basal controlado; **rescate** de acción rápida): **incidental** (previsible: movilizaciones, curas, tos), **espontáneo** (impredecible) y **fallo de final de dosis** (antes de la toma siguiente: **subir la dosis basal**).

Paciente	Escala	Claves
Comunicativo	**EVA**	Línea de **10 cm sin números**; **1-3 leve, 4-6 moderado, 7-10 intenso**
	Numérica (0-10) y **verbal** (nada, leve, moderado, intenso, insoportable)	La numérica es la más rápida
No comunicativo (crítico, intubado)	**Campbell**	5 ítems conductuales (0-10); objetivo **< 4**
Demencia avanzada	**PAINAD**	5 ítems (**respiración**, vocalización, cara, lenguaje corporal, consuelo), 0-10
Demencia	**Abbey**	**6 ítems**: añade **cambios fisiológicos** (pulso, TA, temperatura) y **físicos** (lesiones); grave **≥ 14**

- **Vía subcutánea**: de elección en paliativos cuando no se puede usar la oral; bolos con palomilla o **infusores** (zonas: subclavicular, deltoides, abdomen, muslo). **Se pueden mezclar**: morfina, midazolam, haloperidol, butilbromuro de escopolamina, metoclopramida, tramadol. **Por separado**: **dexametasona** (precipita), diclofenaco, ketorolaco; el **diazepam no se pone SC**.
- **Escalera analgésica de la OMS** (con «**ascensor**» para saltar escalones si el dolor es intenso):

Escalón	Dolor	Fármacos
1.º	Leve	**No opioides**: paracetamol, metamizol, AINE (**techo** terapéutico)
2.º	Moderado	**Opioides débiles** (tramadol, codeína) ± 1.º escalón (con techo)
3.º	Intenso	**Opioides potentes** (morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina): **sin techo**
4.º	Refractario	**Técnicas invasivas**: bloqueos nerviosos, vía epidural o intratecal, ketamina o lidocaína IV, neurocirugía

- **Nunca combinar opioides débiles y potentes** (competencia por el receptor). Los **coadyuvantes** pueden añadirse en cualquier escalón.

4. Duelo

- Proceso **normal y adaptativo** ante una pérdida. Manifestaciones físicas (vacío, opresión, nudo en la garganta, cansancio), cognitivas (incredulidad, falta de concentración; **sentir la presencia del fallecido** o creer oírle es **normal**

al principio), emocionales (tristeza, **culpa**, **ira** —a menudo contra el equipo— y **alivio**, que también da culpa) y conductuales (insomnio, cambios de apetito, aislamiento).

- **Kübler-Ross** (**fases** emocionales, no siempre en orden): **negación**, **ira** («¿por qué a mí?»), **pacto**, **depresión** y **aceptación**.
- **Worden** (**tareas** activas): **I. aceptar la realidad** de la pérdida (ver el cuerpo, los ritos ayudan); **II. elaborar el dolor** (sentirlo: **medicar en exceso con ansiolíticos lo bloquea**); **III. adaptarse** a un mundo sin el fallecido (externa, interna, espiritual); **IV. recolocarlo emocionalmente** y seguir viviendo.

Tipo de duelo	Rasgo
Normal	Duración variable (≈ 6 meses-2 años), con **reacciones en aniversarios**
Anticipado	Empieza **antes** de la muerte (demencias, cáncer avanzado)
Enmascarado	Se expresa con **síntomas físicos** sin relacionarlos con la pérdida
Crónico	Se **estanca** años con la misma intensidad (tarea II)
Retrasado o inhibido	No se expresa al principio («ser fuerte») y **estalla después** ante una pérdida menor
Trastorno por duelo prolongado	Añoranza y dolor incapacitantes **> 6 meses (CIE-11) o > 12 meses (DSM-5-TR)**

5. Cuidador principal y familia

- **Cuidador principal**: persona del entorno que asume la mayor parte del cuidado **sin remuneración**; perfil: **mujer** (hija o esposa), ≈ 59 años. Riesgos: **sobrecarga**, burnout y **claudicación familiar**. Según estudios del SMS, al inicio **≈ 40% no muestra sobrecarga**: hay que intervenir **antes** de que aparezca. La **lumbalgia** es su principal problema físico.
- **Escala de Zarit** (22 ítems, 0-88): **≤ 46 sin sobrecarga**, **47-55 leve**, **≥ 56 intensa**. **Versión abreviada de 7 ítems**: sobrecarga a partir de **17 puntos**.
- Intervenciones: **educación** (movilizaciones, **higiene postural**, curas, medicación SC), **afrontamiento** (delegar, no sentirse culpable por descansar), **recursos** (trabajo social, ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, **respiro familiar**) y **grupos de ayuda mutua**.

6. Paciente crónico

- **Paciente pluripatológico (criterios de Ollero)**: enfermedades crónicas de **dos o más categorías clínicas distintas** (cardíaca; renal, autoinmune u osteoarticular; respiratoria; digestiva-hepática; neurológica y cognitiva; arteriopatía y diabetes con lesión de órganos; oncohematológica). Tres enfermedades de la **misma** categoría **no** bastan. Pronóstico a 12 meses: **índice PROFUND**.
- **Enfermera gestora de casos**: captación activa de pacientes complejos, **valoración integral en domicilio** (paciente y cuidador), **alta planificada** y **coordinación** de niveles y recursos; no sustituye a los profesionales de referencia.
- **Valoración geriátrica integral**:

Esfera	Escala	Claves
Funcional (ABVD)	**Barthel** (10 actividades, 0-100)	**< 20 total**, 20-35 grave, 40-55 moderada, ≥ 60 leve, 100 independiente; **en silla de ruedas, máximo 90**
Funcional (AIVD)	**Lawton y Brody** (8 ítems, 0-8)	Teléfono, compras, cocina, casa, ropa, transporte, medicación, dinero; valorar la **capacidad** sin sesgo de género
Cognitiva	**Pfeiffer** (10 preguntas)	**Cuenta errores** (más = peor): **0-2 normal**, 3-4 leve, 5-7 moderado, **8-10 grave**. Se **resta 1** error si **no tiene estudios** y se **suma 1** si tiene **estudios superiores**
Cognitiva	**MEC de Lobo**	Cuenta **aciertos** (más = mejor)
Social	**Gijón** (5 áreas de 1 a 5, total 5-25)	**< 10** buena o aceptable; **10-14 riesgo social**; **≥ 15 problema social**
Afectiva	**Yesavage GDS-15**	0-4 normal; **≥ 5** probable depresión; ≥ 10 establecida
Nutricional	**MNA**	**< 17 malnutrición**; **17-23,5 riesgo**; ≥ 24 normal

TRAMPAS DE EXAMEN

! Dolor total (Saunders): **físico, emocional, social y espiritual**.

! NECPAL: **pregunta sorpresa a 12 meses**; vale para **enfermedades no oncológicas**.

! Estertores: **postura lateral + butilbromuro de escopolamina**; **no aspirar**.

! **Sedación: solo con síntoma refractario; midazolam primero; opioides nunca para sedar.**

! LET ≠ sedación ≠ eutanasia.

! Somático = localizado; visceral = difuso con náuseas y sudor; neuropático = quemazón y descargas.

! **Fallo de final de dosis** → subir la basal, no rescates.

! Abbey es la única con **cambios fisiológicos y físicos** (grave ≥ 14).

! No mezclar **tramadol con morfina**; la **dexametasona** va sola en la vía SC.

! **Kübler-Ross = fases (negación, ira, pacto, depresión, aceptación); Worden = tareas (aceptar, elaborar, adaptarse, recolocar).**

! Zarit **≥ 56** (22 ítems) o **≥ 17** (7 ítems).

! Pluripatológico: **≥ 2 categorías distintas** de Ollero.

! Barthel en silla de ruedas: **máximo 90**; Pfeiffer cuenta **errores**; Gijón **≥ 15** = problema social; MNA **< 17** = malnutrición.